Clopidogrel 복용 환자의 산분비억제제 선택 확인표

약물 대사 경로와 불응성 속쓰림의 원인을 함께 확인합니다.

같은 효소를 쓰는가, 다른 경로인가

Clopidogrel: CYP2C19에서 활성화

PPI 병용

PPI와 CYP2C19 대사 경로 공유
강의: PPI 친화도가 더 높아
clopidogrel 활성화에 영향

P-CAB 병용

P-CAB은 CYP3A4 대사
강의: clopidogrel과
대사 경로가 분리됨

강의는 효소 경로 차이를 약제 선택의 고려점으로 설명했습니다.

CYP2C19 개인차 — 교재 제시 수치

표현형	백인	아시아인
Extensive metabolizer · 효과 저하	22–30%	26–47%
Poor metabolizer · 독성 증가	2.5–3.5%	13.4–22.5%

불응성 GERD로 의뢰된 216명 — 연자 자료

24시간 산도검사 분류	비율
실제 산 노출 GERD / 역류 과민성 / 기능성 가슴쓰림	14.8% / 33.8% / 51.4%
빠른 대사형(EM+UM) / 느린 대사형(IM+PM)	47.2% / 52.8%

약효가 낮을 때의 해석

약제 선택과 환자 대사 특성을 함께 보되, 속쓰림 불응을 모두 산 역류로 간주하지 않습니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 속쓰림 환자의 진단과 치료(김도훈)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-clopidogrel-acid-suppression/